针药联合言语康复训练治疗脑卒中后失语症临床观察

刘金华

（枣庄市薛城区人民医院康复医学科，山东 枣庄 277000）

摘　要：目的　分析针药联合言语康复训练治疗脑卒中后失语症的效果。**方法**　选取2021年2月—2022年9月于枣庄市薛城区人民医院就诊的60例脑卒中后失语症患者，通过随机抽签分为两组。对照组采取常规言语康复训练，观察组联合针药治疗，比较两组临床疗效、语言和神经功能、生活质量。**结果**　观察组治疗总有效率93.33%（28/30）高于对照组的73.33%（22/30）（$P<0.05$）。治疗后，两组语言功能评分均显著升高，美国国立卫生研究院卒中量表（NIHSS）评分均显著下降，且观察组均优于对照组（$P<0.05$）；两组生活质量评分均显著升高，且观察组高于对照组（$P<0.05$）。**结论**　针药联合语言康复训练对脑卒中后失语症患者具有较为显著的治疗效果，可以减轻其神经功能缺损、改善其语言功能、提升其生活质量，值得临床使用。

关键词：痹证；脑卒中后失语症；针药疗法；言语康复训练；中西医结合疗法

doi:10.3969/j.issn.1672-2779.2025.16.046　　**文章编号：**1672-2779（2025）-16-0158-03

Acupuncture and Medicine Combined with Speech Rehabilitation Training in the Treatment of post-stroke Aphasia

LIU Jinhua

(Department of Rehabilitation Medicine, Xuecheng District People's Hospital, Shandong Province, Zaozhuang 277000, China)

Abstract: Objective To analyze the effect of acupuncture and medicine combined with speech rehabilitation training on post-stroke aphasia. **Methods** Sixty patients with post-stroke aphasia who attended Xuecheng District People's Hospital from February 2021 to September 2022 were selected and divided into two groups by random drawing. The control group received routine speech rehabilitation training, while the observation group was given acupuncture and medicine combined with speech rehabilitation training on the basis of the control group. The clinical efficacy, language and neurological functions, and quality of life were compared between the two groups. **Results** The total effective rate of the observation group was 93.33% (28/30), which was higher than 73.33% (22/30) of the control group ($P<0.05$). After treatment, the language function scores of both groups increased significantly, while the scores of the National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS) decreased significantly, with the observation group performing better than the control group ($P<0.05$). The quality of life scores of both groups increased significantly, and the observation group's score was higher than that of the control group ($P<0.05$). **Conclusion** Acupuncture and medicine combined with speech rehabilitation training has a relatively significant therapeutic effect on patients with post-stroke aphasia. It can reduce their neurological deficits, improve their language function, and enhance their quality of life, and is worthy of clinical application.

Keywords: arthralgia syndrome; post-stroke aphasia; acupuncture and medicine therapy; speech rehabilitation training; therapy of integrated traditional Chinese and Western medicine

脑卒中是临床比较常见的一种脑血管疾病，一般为急性发病，可导致脑组织急性缺血、缺氧，引起脑组织坏死和神经组织坏死[1]。本病可对患者神经功能造成损害，引起偏瘫、失语、吞咽障碍、认知力障碍等多种后遗症；其中失语症是发生率较高的一种后遗症，对患者日常生活和社交有着比较严重的影响[2, 3]。传统西医一般会采取营养神经治疗、言语康复训练等方式干预，但效果比较有限。近几年，中医在临床中发挥出了较好的应用效果，中药及针灸是比较典型的中医治疗方式，临床使用比较广泛，也获得了广大患者的青睐[4, 5]。对此，文章分析了针药联合言语康复训练治疗脑卒中后失语症的效果，选取了2021年2月—2022年9月枣庄市薛城区人民医院收治的60例患者进行分析，内容如下。

1　资料与方法

1.1　一般资料　选取2021年2月—2022年9月于枣庄市薛城区人民医院就诊的60例脑卒中后失语症患者，通过随机抽签分为对照组和观察组，各30例。对照组男18例，女12例；年龄61～83岁，平均（72.16±1.52）岁；脑出血16例，脑梗死14例。观察组男19例，女11例；年龄60～83岁，平均（72.22±1.38）岁；脑出血17例，脑梗死13例。两组一般资料比较，差异无统计学意义（$P>0.05$），具有可比性。本研究符合世界卫生组织《涉及人的生物医学研究国际伦理准则》和世界医学协会《赫尔辛基宣言》相关规定。

1.2　入选标准　纳入标准：西医诊断符合《中国急

中国知网　https://www.cnki.net

性缺血性脑卒中诊治指南2018》[6]相关标准；中医诊断符合《中风病证候诊断标准的研究》[7]中的相关标准；同意研究。排除标准：非卒中导致的失语；存在肝、肾等脏器功能异常；中途退出；存在精神障碍；存在视觉及听力障碍；存在针灸治疗禁忌证。

1.3 治疗方法

1.3.1 对照组 行言语康复训练。首先，展开口腔发音训练，如鼓腮、吹蜡烛、舔嘴角、伸缩舌头、噘嘴、张口、卷曲舌头等动作，每个动作5～10次，每天3～5组，训练时间不低于10 min。其次，行发音训练，从声母、韵母的简单发音训练开始，逐步开展词语、句子的发声训练，循序渐进地增加难度。每天3次，每次不少于10 min。最后，逐步进行读书、读报等阅读活动，进行记忆力训练，制作训练卡片，让患者认识卡片中的事物，包括文字、图画等，指出某一物品，要求患者大声说出其名字，以刺激记忆，而后扣下图片，让患者回忆并说出图片中的内容。共训练8周。

1.3.2 观察组 在对照组基础上，联合针药治疗。（1）药物组方：地龙9 g，天麻9 g，法半夏9 g，石菖蒲9 g，茯苓9 g，川芎12 g，白术12 g，赤芍12 g，丹参15 g。上药每日1剂，加水1000 mL，煎煮取汁200 mL，每天分2次服。共治疗8周。（2）针灸操作：取患者率谷、风府、廉泉、哑门、百会等穴位针刺，采用一次性使用针灸针（苏州医疗用品厂有限公司，苏食药监械生产许20010020号，规格：0.25 mm× 40 mm，0.25 mm×25 mm），在患侧穴位颞前斜线下2/5处，倾斜15°角进针，深度为15 mm；进针后快速提、插、捻、转，得气后留针30 min。每天1次，治疗5 d后间隔2 d。共治疗8周。

1.4 观察指标 （1）语言功能评分：参照《失语症》[8]中的相关描述，就理解能力、阅读能力、复述能力及书写能力4个维度进行评分，总分100分，均为正向评分。（2）神经功能评分：采用美国国立卫生研究院卒中量表（NIHSS）评估，总分42分，分数越高代表神经功能损害越重。（3）临床疗效：参考以下标准评估：语言功能基本恢复正常，神经功能缺损评分降低≥90%，为基本治愈；语言功能显著改善，可正常社交，神经功能缺损评分降低70%～89%，为显效；语言功能有恢复但对日常表达仍有影响，神经功能缺损评分降低50%～69%，为有效；未达以上描述为无效。总有效率=（基本治愈+显效+有效）例数/总例数×100%。（4）生活质量：采用健康调查简表（SF-36）评估，有生理、心理、社会、角色4个维度，总分100分，均为正向评分。

1.5 统计学方法 将SPSS 23.0作为统计学工具，计数资料以率（%）表示，行χ^2检验；计量资料以（$\bar{x} \pm s$）表示，行t检验。$P<0.05$为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 临床疗效 观察组治疗总有效率93.33%（28/30）高于对照组的73.33%（22/30），差异有统计学意义（$P<0.05$）。见表1。

2.2 语言和神经功能评分 治疗前，两组语言功能及NIHSS评分比较，差异无统计学意义（$P>0.05$）。治疗后，两组语言功能评分均显著升高，NIHSS评分均显著下降，且观察组各项数据波动均较对照组更为明显，差异均有统计学意义（$P<0.05$）。见表2。

2.3 SF-36评分 治疗前，两组SF-36评分比较，差异无统计学意义（$P>0.05$）。治疗后，两组SF-36评分均较治疗前升高，且观察组各项评分均高于对照组，差异均有统计学意义（$P<0.05$）。见表3。

3 讨论

脑卒中后失语症是脑卒中后发生率较高的一种后遗症，目前临床尚无有效治疗方式，一般通过语言康复训练逐步恢复患者的语言功能，但治疗周期长且对于部分患者实施难度较大，故效果差异也比较大[9，10]。在中医学中，脑卒中后失语症属于“痹证”“舌喑”“喑痱”范畴；病因在于气血瘀滞、脉络不通，致聚湿成痰，主要受到痰、火、虚、瘀等几个因素的影响，而舌属心肝脾肾所系，故中风后出现不能语言等病证[11，12]。

表1 两组脑卒中后失语症患者临床疗效比较

组别	例数	基本治愈/例	显效/例	有效/例	无效/例	总有效率/%
观察组	30	23	3	2	2	93.33
对照组	30	15	4	3	8	73.33
χ^2值						4.320
P值						0.038

中国知网 https://www.cnki.net

表2　两组脑卒中后失语症患者治疗前后语言和神经功能评分比较　（$\bar{x}\pm s$，分）

项目		时间	观察组（30例）	对照组（30例）	t值	P值
语言功能评分	理解能力	治疗前	20.53±1.32	20.44±1.24	0.272	0.786
		治疗后	52.13±2.53[1)]	43.67±3.31[1)]	11.122	0
	阅读能力	治疗前	17.32±2.13	17.35±2.72	0.048	0.962
		治疗后	52.12±2.74[1)]	45.95±2.57[1)]	8.996	0
	复述能力	治疗前	22.12±1.46	22.03±1.58	0.229	0.820
		治疗后	70.35±3.63[1)]	56.72±3.83[1)]	14.147	0
	书写能力	治疗前	17.11±2.42	17.35±2.18	0.404	0.688
		治疗后	51.46±2.74[1)]	47.72±3.11[1)]	4.942	0
NIHSS评分		治疗前	13.73±2.74	13.68±2.46	0.074	0.941
		治疗后	5.12±1.99[1)]	7.52±1.16[1)]	5.707	0

注：与本组治疗前比较，[1)]$P<0.05$。

表3　两组脑卒中后失语症患者治疗前后SF-36评分比较　（$\bar{x}\pm s$，分）

项目	时间	观察组（30例）	对照组（30例）	t值	P值
生理	治疗前	62.42±3.74	61.46±3.56	1.018	0.313
	治疗后	78.52±2.56[1)]	70.35±2.11[1)]	13.489	0
心理	治疗前	60.45±3.05	60.47±3.14	0.025	0.980
	治疗后	78.56±3.04[1)]	71.03±2.68[1)]	10.177	0
社会	治疗前	58.63±3.65	57.83±3.46	0.871	0.387
	治疗后	79.02±2.73[1)]	71.24±3.17[1)]	10.186	0
角色	治疗前	59.52±3.54	59.05±3.99	0.483	0.621
	治疗后	80.24±3.46[1)]	73.63±3.94[1)]	6.905	0

注：与本组治疗前比较，[1)]$P<0.05$。

本研究以针灸治疗脑卒中后失语症，选取百会穴（治疗失语的主穴）、哑门穴（治疗舌强不语的主穴）针刺，可达到活血行气、疏通经络的效果，同时还可刺激大脑皮层，有利于神经功能的恢复[13]。临床实际操作中，再根据患者病证选取其他辅助穴位，可达对症治疗的效果。中药方剂方面，本研究选取具有活血化瘀、疏通经络、活血行气、疏风止痛等作用的药物，例如丹参、茯苓、川芎、白术、赤芍等，方药整体可达行气祛风、开窍化瘀的功效，正对应了患者的病证。

综上所述，针药联合言语康复训练治疗脑卒中后失语症，有着比较理想的综合效果，值得推荐。

参考文献

[1] 糜华，吴珊珊，黄美维，等．健康赋权模式在脑卒中后失语症老年患者中的应用效果[J]．中国当代医药，2023，30(8)：189-192.
[2] 吴丽丽．针刺联合言语康复训练对脑卒中后失语症患者的影响[J]．实用中西医结合临床，2022，22(2)：117-119，128.
[3] 李小霞，张莹莹．针药联合言语康复训练治疗脑卒中后失语症患者的疗效探究[J]．实用中西医结合临床，2021，21(14)：47-48.
[4] 刘勇涛，刘晓鑫，谢立娟，等．圣愈汤结合醒脑开喑针刺疗法治疗脑卒中后失语症临床疗效及安全性观察[J]．中华中医药学刊，2022，40(2)：211-214.
[5] 丁晔．基于动态评估的康复训练对脑卒中后失语症患者的疗效与生活质量的影响[J]．护理实践与研究，2021，18(9)：1265-1268.
[6] 中华医学会神经病学分会，中华医学会神经病学分会脑血管病学组．中国急性缺血性脑卒中诊治指南2018[J]．中华神经科杂志，2018，51(9)：666-682.
[7] 任占利，郭蓉娟．中风病证候诊断标准的研究[J]．北京中医药大学学报，1996，19(4)：49-50.
[8] 高素荣．失语症[M]．2版．北京：北京大学医学出版社，2006：1-593.
[9] 聂涛，黄宇，莫彩霞．语言康复训练配合头电针治疗脑卒中后失语症患者的效果分析[J]．中医临床研究，2020，12(29)：80-82.
[10] 蔡婉青，刘海艳．中药熏洗和中医康复护理改善脑卒中后偏瘫肢体功能的临床效果[J]．中国中医药现代远程教育，2022，20(23)：147-149.
[11] 鲍文，穆燕芳，谢财忠，等．督脉针刺合舌三针辅助言语康复训练治疗脑卒中后失语症疗效及作用机制探讨[J]．针灸临床杂志，2020，36(6)：32-35.
[12] 刘洪涛．扶正补土针法对脑卒中偏瘫患者肢体康复的影响[J]．中国中医药现代远程教育，2022，20(1)：123-125.
[13] 李欣欣，王诗尧．中医护理在脑卒中功能缺损症状康复中的运用[J]．中国中医药现代远程教育，2023，21(4)：177-179.

（本文编辑：柳　歌　收稿日期：2023-09-06）

中国知网　https://www.cnki.net